

SILVIA REGINA COSTA PEREIRA

MEDICAMENTOS:	
SINTOMAS/QUEIXAS	HAS / Pré diabética / Depressão / Cefaleia intensa
BANHEIRO	2 à 3x
HORA QUE ACORDA	7:30
HORA QUE DORME	23:30
	IAH: 31,1
PRÁTICA EXERCÍCIO	nao faz
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES	
CAFE:	ALMOÇO: LANCHE: JANTA:
30/11	1º retorno: Relato que teve dificuldade para virar na cama. Mas houve melhora da cefaleia P = 8.8 cmH ₂ O IAH = 5.1 m. de uso: 6h32' fua
08/12 22	P = 8.0 cmH ₂ O IAH = 5.2 e/h m. de uso: 6h30' Bem adapt. / relata melhora da cefaleia Mais disposta, edema ↓ em mmII. fua
22/12 22	P = 8.0 cmH ₂ O IAH = 4.8 e/h m. de uso: 7h Acabou a dor de cabeça, melhora da disposição fua
03/03 23	P = 7.0 IAH = 5.1 m. de uso 4h30' fua
16/05 23	P = 6.0 Fuga = 4.8 e/lpm IAH = 3 e/h Bem adaptada, sem cefaleia. Melhora da disposição fua
18/07/23	P = 5.1 cmH ₂ O IAH = 2.9 e/h m. de uso = 6h20' fuga = 11.6 e/min Pro: 5.99 cmH ₂ O
19/09 23	P = 5.2 cmH ₂ O IAH = 3 e/h m. de uso: 6h30' Fuga = 3.4 e/pm. ajusto o CPAP. fua

21/01 P = 7 cmH₂O
23 IAH = 3 e/h
m. de uso: 6h39

Bem adaptada, n sente cefaleia. — Jua

23/01 P = 7.0 cmH₂O
24 IAH = 2.7 e/h
m. de uso: 6hr

Bem adaptada, s/ queixas. — Jua.

03/04 P = 7.0 cmH₂O
24 IAH = 3.2 e/h
m. de uso: 6h20'

Bem adaptada, s/ queixas.

15/04 P = 6.5 cmH₂O
24 IAH = 3.2 e/h
m. de uso: 7h15'

Bem adaptada, oriento p/
que 4 o T^o sono. Jua

16/10 P = 5.3 cmH₂O
24 IAH = 4.4 e/h
m. de uso: 6h15'

Bem adaptada
Dilata tirar a máscara
durante a noite
Natasha

23/01 P = 5.3 cmH₂O
25 IAH = 3.6 e/h
m. de uso: 7hr
fuga = 0.1 lpm.

Jua Claudis

05/06 P = 5.3 cmH₂O
25 IAH = 4.23 e/h
m. de uso: 6h55'
fuga: 3.0 lpm

Treco almofada N30

Natasha

Nome: SILVIA REGINA COSTA PEREIRA

Data de Nascimento: 8-8-1959

IMC: 32,35

Sexo: Feminino

Data do exame: 19-02-2020

Peso: 87 kg

Altura: 1,64 m

Médico: DR. JOSÉ CASSIO DE ABREU

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 19-02-2020, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 558,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 51,5 e 198,5 minutos. O tempo total de sono foi de 352,0, eficiência de 63,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,1%; estágio N2: 61,2%; estágio N3: 13,9%; sono REM: 21,7%. O índice de despertares foi de 13,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 31,0, sendo elas 101 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 81 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e mínima de 62%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 82 bpm e NREM de 51 - 81 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

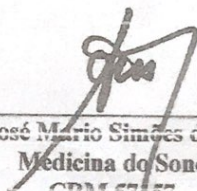
1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 31,0/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. São 2=62%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (4,3/hora);
8. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

Mônica Lopes
99778.4933
3341.9008.
CPAP.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157